Síntomas digestivos y hemorragia digestiva

SEMIOLOGIA · Clase 21 · dónde sangra, por qué vomita y de qué tramo viene la diarrea

1 · DOLOR ABDOMINAL: MECANISMO Y FORMA

Dolor abdominal
síntoma más frecuente del aparato digestivo; se describe por mecanismo y por forma

si estira la víscera → **Visceral** (F6)
estiramiento de aferentes de una víscera hueca o de la cápsula de un órgano macizo
en víscera hueca se siente → **Cólico** (F6)
contracciones del músculo liso; el más frecuente
por frecuencia va primero → Mecanismo, forma, sitio e irradiación orientan el órgano afectado

si irrita el peritoneo → **Parietal** (F6)
irritación del peritoneo parietal
su sitio orienta → Mecanismo, forma, sitio e irradiación orientan el órgano afectado

si se proyecta lejos → **Referido** (F6)
se siente a distancia; apendicitis: empieza en epigastrio y migra a fosa ilíaca derecha
su trayecto orienta → Mecanismo, forma, sitio e irradiación orientan el órgano afectado

además se describe por su forma → **Otras formas** (F6)
Terebrante: úlcera péptica · **Urente**: gastritis o úlcera · **Lancinante**: pancreatitis · **Gravativo**: hepato o esplenomegalia
la forma sugiere órgano → Mecanismo, forma, sitio e irradiación orientan el órgano afectado

2 · HEMORRAGIA: ARRIBA O ABAJO DE TREITZ

Ángulo de Treitz
cuarta porción del duodeno: separa la hemorragia alta de la baja
por encima sangra la → **Hemorragia alta**
hematemesis con o sin melena
por debajo sangra la → **Hemorragia baja**
enterorragia (roja, abundante, con coágulos) o hematoquecia

Úlcera péptica (F8 · F10)
gástrica o duodenal; erosiona un vaso de su fondo; causa principal de hemorragia alta (literatura: más a menudo duodenal)
sangra por encima de Treitz → **Hemorragia alta**
hematemesis con o sin melena

Otras causas altas
várices esofágicas, esofagitis, Mallory-Weiss (laceración del cardias por vómito intenso), tumores, aspirina, AINE, corticoides, anticoagulantes
también sangran arriba → **Hemorragia alta**
hematemesis con o sin melena

Causas bajas
hemorroides, fisuras, pólipos, cáncer de colon, diverticulosis, colitis, Meckel
sangran por debajo de Treitz → **Hemorragia baja**
enterorragia (roja, abundante, con coágulos) o hematoquecia

Hemorragia alta (hematemesis con o sin melena)
la sangre digerida sale como → **Melena**
heces negras como brea; sangre digerida; requiere al menos 150 ml de una vez (2018: 60-150 ml)
si se pierde menos queda → **Pérdidas menores**
solo sangre oculta o tacto rectal

Hemorragia baja (enterorragia (roja, abundante, con coágulos) o hematoquecia)
si es roja viva y escasa → **Hematoquecia** (F7)
sangre roja viva y escasa de origen proctológico (recto o ano); no alcanza a digerirse
se confirma con → Cuantificar la pérdida, identificar y controlar la fuente (endoscopia primero)

orienta la conducta → **Pérdidas menores**
solo sangre oculta o tacto rectal

según cuánta se pierde → **Hasta 500 ml** (F9)
sin signos; rara vez síncope
si sigue sangrando → **500 a 1.500 ml** (F9)
taquicardia, hipotensión postural, pulso filiforme, piel fría y húmeda, lipotimia
si supera 1.500 ml → **Más de 1.500 ml** (F9)
shock hipovolémico
obliga a controlar la fuente → Cuantificar la pérdida, identificar y controlar la fuente (endoscopia primero)

la sangre digerida produce → **Hiperazoemia digestiva**
urea alta por la sangre digerida, con creatinina normal
orienta la conducta → Cuantificar la pérdida, identificar y controlar la fuente (endoscopia primero)

3 · CUÁNTA SANGRE SE PERDIÓ

Ver: Hasta 500 ml · 500 a 1.500 ml · Más de 1.500 ml · Hiperazoemia digestiva

4 · DIARREA: DELGADO O COLON

Diarrea
heces de consistencia disminuida y más frecuentes; crónica si dura más de 1 mes

si nace en el delgado → **Diarrea alta** (delgado) (F3)
voluminosa, hasta 10 al día, dolor periumbilical, restos de alimentos, sin tenesmo
mucho volumen sin tenesmo → Volumen, frecuencia, dolor y tenesmo localizan el tramo

si nace en el colon → **Diarrea baja** (colon) (F3)
poco volumen, más de 10 al día, dolor infraumbilical, tenesmo, moco, pus o sangre
poco volumen con tenesmo → Volumen, frecuencia, dolor y tenesmo localizan el tramo

un mecanismo es la → **Secretora** (F4)
la toxina del cólera obliga a la mucosa a secretar agua y electrolitos
la pérdida masiva de agua da → **Deshidratación**
mucosas secas, taquicardia, hipotensión postural
obliga a que → En toda diarrea aguda se vigila la deshidratación

lo muestra el → **Cólera** (F4)
diarrea acuosa y masiva sin destruir la mucosa

5 · MECANISMOS Y MALABSORCIÓN

Giardia (F11)
tapiza la mucosa del delgado e impide absorber (también Strongyloides)
produce → **Malabsorción** (F11)
diarrea crónica con esteatorrea
consume al paciente → **Consecuencias** (F11)
pérdida de peso, glositis, anemia, hipocalcemia (tetania), hemorragias por falta de vitamina K, edema y ascitis
obliga a → Identificar la causa y reponer los déficits

si impide absorber hay → **Malabsorción** (F11)
diarrea crónica con esteatorrea
consume al paciente → **Consecuencias** (F11)
pérdida de peso, glositis, anemia, hipocalcemia (tetania), hemorragias por falta de vitamina K, edema y ascitis
obliga a → Identificar la causa y reponer los déficits

6 · ESTREÑIMIENTO

Estreñimiento (F5)
evacuación difícil, heces duras; espontánea cada 3 días o más, con dificultad o laxantes
se mide contra el → **Ritmo normal** (F5)
de 3 al día a 1 cada 3 días
se debe sobre todo a → **Causa más común** (F5)
dieta pobre en fibra; más en mujeres y extremos de la vida
se corrige con la dieta → Se corrigen los factores reversibles (fibra, fármacos, laxantes)

7 · SÍNTOMAS QUE VIENEN DE FUERA

Halitosis respiratoria (F1)
rinitis, sinusitis y bronquiectasias: secreciones estancadas que se descomponen
descompone secreciones y da → **Halitosis** (F1)
local (higiene, caries, tabaco), respiratoria o digestiva (dispepsia, obstrucción, Zenker)
según el origen se trata → Según el origen se trata el foco que retiene o descompone

Presión endocraneana alta (F2)
tumor o edema cerebral estimula directamente el centro del vómito
estimula el centro y da → **Vómito en proyectil** (F2)
brusco y explosivo, sin náuseas ni arcadas
por eso obliga a buscar causa → Obliga a buscar una causa extradigestiva (hipertensión endocraneana)

síntoma · mecanismo · ejemplo · desenlace · concepto · causa · síndrome · signo · diagnóstico · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología 2020 (09a, 09c, 09e) — teoría del docente (= literatura)